

Saúde na Última Semana

Revista Eletrônica VIA sobre os fatos que alteraram o cuidado, a saúde pública, a ciência e a tecnologia nesta semana — com anúncio separado de implementação e evidência.

• EDIÇÃO DE 6 DE SETEMBRO DE 2026

• SEMANA DE 30 DE AGOSTO A 6 DE SETEMBRO DE 2026

| BRASIL

CRITÉRIO EDITORIAL

Critério editorial desta edição: entrou apenas o que alterou norma, capacidade instalada, organização do cuidado, produção científica ou risco sanitário de forma material. Anúncio foi separado de implementação; intenção política, de entrega assistencial; tecnologia, de benefício clínico demonstrado.

NESTA EDIÇÃO

O que mudou na saúde nesta semana

| ATUALIZADO EM 6 DE SETEMBRO DE 2026

EDIÇÃO 06.09.2026 · ANO I

Fonte editorial versionada em Markdown

A semana foi menos sobre “uma grande descoberta” e mais sobre **infraestrutura de sistema**. O SUS ganhou uma nova exigência legal para protocolos de urgência cardiovascular com medidas trombolíticas em UPA; a plataforma brasileira de RNA

avançou simultaneamente em capacidade industrial-científica e ensaio clínico; a transformação digital hospitalar passou a operar com uma central nacional de UTIs conectadas; o Ministério da Saúde publicou um cronograma para abrir 109 bases de dados; a atenção primária foi incluída em uma compra nacional de ultrassons portáteis; e o programa Agora Tem Especialistas ampliou contratos com a rede privada — mas os números de execução ainda estão muito aquém dos números anunciados.

A leitura correta da semana é, portanto, **capacidade potencial em expansão, com implementação ainda desigual**.

01

Urgência cardiovascular: trombólise em UPA deixa de ser apenas possibilidade operacional e entra na lei

02

RNA no Brasil: a diferença entre “ter uma plataforma” e ter um produto começou a ficar mensurável

03

SUS Digital: 60 leitos conectados, uma central nacional e 109 bases programadas para abertura

04

Atenção Primária: 500 ultrassons de bolso podem mudar a consulta — se vierem acompanhados de competência

05

Oncologia: o SUS está deixando de tratar medicamento oncológico como exceção administrativa permanente

06

“Agora Tem Especialistas”: o dado importante é a distância entre contratar e entregar

07

Pesquisa Nacional de Saúde Mental: ainda não há resultado — e isso é importante dizer

08

Multivacinação terminou; vacinação não

09

Saúde e clima: preparação para El Niño entrou na agenda operacional

10

Anvisa: terminou a transição regulatória para parte dos suplementos alimentares

11

Método editorial

Revista editorial de utilidade pública, compilada de fontes oficiais e literatura científica na data acima. Confira a fonte primária antes de agir ou compartilhar.

01 · NESTA EDIÇÃO

Urgência cardiovascular: trombólise em UPA deixa de ser apenas possibilidade operacional e entra na lei

O que mudou

Foi sancionada a **Lei nº 15.494, de 2 de setembro de 2026**, que determina a criação de protocolos de atendimento para urgências cardiovasculares no SUS e explicita a inclusão de **medidas trombolíticas em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)**, observados critérios de segurança e eficácia definidos pelo Poder Executivo.

A lei entra em vigor **180 dias após a publicação**.

O que não mudou

Trombolíticos já faziam parte dos protocolos assistenciais do SUS para infarto agudo do miocárdio e AVC isquêmico. O próprio Ministério da Saúde reconhece que a aquisição dos medicamentos vinha sendo feita pelos gestores locais e que o uso já podia ocorrer em serviços de urgência, inclusive em determinadas unidades do SAMU 192.

Portanto, a mudança desta semana **não significa que toda UPA brasileira passou a ter trombolítico disponível em 2 de setembro**. O ganho jurídico é outro: a oferta e os protocolos deixam de depender apenas de arranjos programáticos e passam a ter previsão legal explícita, com um comitê nacional encarregado de acompanhar a implementação das linhas de cuidado tempo-dependentes para AVC e IAM.

Por que importa

Em reperfusão, geografia e tempo são variáveis clínicas. A norma pode reduzir a distância entre o primeiro contato do paciente e uma intervenção efetiva, particularmente onde angioplastia primária ou unidade de AVC não estão disponíveis dentro da janela adequada.

O gargalo, contudo, não é apenas comprar o medicamento. Uma estratégia de trombólise segura exige diagnóstico rápido, ECG ou neuroimagem quando indicada, reconhecimento de contraindicações, protocolo de transferência, monitoramento de complicações e integração com a referência definitiva.

O melhor indicador para acompanhar daqui em diante não é “quantas UPAs aderiram”, mas **tempo porta-diagnóstico, tempo porta-agulha, proporção de pacientes elegíveis reperfundidos, hemorragia maior e desfechos funcionais**.

Fonte primária: Presidência da República — Lei nº 15.494/2026: https://planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15494.htm **Fonte institucional:** Ministério da Saúde — <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/setembro/sancionada-lei-que-preve-oferta-de-tromboliticos-para-tratamento-de-infarto-e-avc-na-rede-de-urgencia-e-emergencia-do-sus/>

02 · NESTA EDIÇÃO

RNA no Brasil: a diferença entre “ter uma plataforma” e ter um produto começou a ficar mensurável

Duas notícias da mesma semana devem ser lidas juntas.

Ensaio clínico nacional de mRNA

A Anvisa informou em 2 de setembro que havia autorizado, em 20 de agosto, o estudo clínico de **Fase 1** da vacina de mRNA da Fiocruz/Bio-Manguinhos contra a Covid-19. O estudo avaliará segurança e imunogenicidade como dose de reforço em **90 adultos saudáveis de 18 a 59 anos**, utilizando mRNA que codifica a proteína Spike da variante XBB.

Isso é avanço real, mas ainda inicial: **Fase 1 não demonstra eficácia clínica nem autoriza uso populacional.**

Centro de Competência em RNA na UFMG

Na mesma semana foi formalizado, em Belo Horizonte, o primeiro **Centro de Competência em Terapias e Vacinas com RNA (CTV-RNA)**, coordenado pelo CTVacinas/UFMG, com aporte de **R\$ 60 milhões**. O Ministério informa um conjunto de investimentos da ordem de **R\$ 210 milhões** em infraestrutura, formação e plataformas relacionadas a RNA.

Há projetos que incluem dengue, malária, chikungunya, doença de Chagas e leishmaniose.

Por que isso merece destaque

“Soberania vacinal” vira slogan vazio se significar apenas que uma universidade publicou bons artigos. Ela começa a existir quando o país domina sucessivamente desenho molecular, formulação, produção em escala, controle de qualidade, ensaio pré-clínico, estudo clínico, regulação, manufatura e entrega ao SUS.

A notícia relevante da semana é que **duas partes diferentes dessa cadeia avançaram ao mesmo tempo**: uma infraestrutura de desenvolvimento em Minas Gerais e um candidato nacional entrando em avaliação clínica.

O teste rigoroso virá depois: capacidade de escalar, custo por dose, estabilidade, independência de insumos críticos, velocidade de atualização da plataforma e desempenho clínico comparável às alternativas disponíveis.

Fontes primárias/institucionais: Anvisa — <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2026/anvisa-autoriza-estudo-clinico-da-fiocruz-com-vacina-de-mrna-para-covid> Ministério da Saúde — <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/setembro/primeiro-centro-de-competencia-em-terapias-e-vacinas-com-rna-e-implementado-no-brasil-com-o-apoio-do-ministerio-da-saude/> Ministério da Saúde — <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/setembro/brasil-consolida-desenvolvimento-de-vacinas-com-rna-mensageiro-e-amplia-respostas-contracrisis-sanitarias/>

03 · NESTA EDIÇÃO

SUS Digital: 60 leitos conectados, uma central nacional e 109 bases programadas para abertura

A transformação digital apareceu nesta semana em duas dimensões que deveriam sempre caminhar juntas: **capacidade operacional** e **observabilidade pública**.

UTIs Inteligentes

O Ministério da Saúde apresentou em 3 de setembro a Central de Comando das UTIs Inteligentes do SUS, sediada no HC-FMUSP. A estrutura conecta atualmente **60 leitos** em seis cidades — Manaus, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre — e recebe em tempo real dados como frequência cardíaca, saturação de oxigênio e pressão arterial.

A expansão anunciada prevê **280 leitos em 14 instituições**.

A pasta descreve a iniciativa como uso de inteligência artificial e “medicina preditiva”. Aqui convém reduzir o hype: integração de sinais vitais, vigilância remota e sistemas de alerta podem ser clinicamente úteis, mas a notícia institucional não apresenta, por si, evidência de redução de mortalidade, tempo de internação ou eventos adversos atribuível ao algoritmo. Esses são desfechos a serem medidos.

A pergunta correta não é “o SUS agora tem IA?”. Tem. A pergunta é: **qual modelo, validado em qual população, com qual sensibilidade, especificidade, taxa de alarmes, governança de dados e efeito sobre desfechos clínicos?**

Plano de Dados Abertos 2026-2028

Também nesta semana foi publicado o novo Plano de Dados Abertos do Ministério da Saúde. O cronograma prevê a abertura de **109 bases até agosto de 2028**, sendo **46 ainda no segundo semestre de 2026**.

O inventário atual identificou **360 bases de dados** no Ministério; até agosto, o Portal de Dados Abertos do SUS disponibilizava 139 conjuntos de dados e 2.845 arquivos estruturados.

Abrir dados não equivale automaticamente a produzir interoperabilidade, qualidade ou utilidade analítica. Mas rastreabilidade, documentação e acesso público são condições importantes para pesquisa, controle social e auditoria de políticas — inclusive das próprias iniciativas de IA do SUS.

A combinação das duas notícias é mais importante que cada uma isoladamente: **quanto mais decisões forem mediadas por infraestrutura digital, maior precisa ser a capacidade de observar, auditar e contestar seus resultados.**

Fontes: Ministério da Saúde — UTIs Inteligentes: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/setembro/ministerio-da-saude-apresenta-central-de-comando-das-utis-inteligentes-do-sus>
Ministério da Saúde — Plano de Dados Abertos: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/setembro/ministerio-da-saude-publica-plano-de-dados-abertos-para-o-periodo-2026-2028/>

04 · NESTA EDIÇÃO

Atenção Primária: 500 ultrassons de bolso podem mudar a consulta — se vierem acompanhados de competência

O Ministério da Saúde registrou ata para aquisição futura de **500 ultrassons portáteis de bolso**, com investimento total previsto de **R\$ 12,58 milhões**, destinados a ações da AgSUS em Unidades Básicas de Saúde de 23 estados e do Distrito Federal.

A entrega está prevista em etapas, entre **60 e 150 dias** após a contratação.

O potencial

POCUS — point-of-care ultrasound — pode aumentar a resolução clínica à beira do paciente: avaliação obstétrica dirigida, bexiga e rins, derrame pleural, avaliação vascular, abscessos, procedimentos guiados e várias perguntas binárias que antes exigiriam encaminhamento para imagem convencional.

O risco do fetiche do equipamento

Ultrassom é profundamente operador-dependente. Um aparelho no bolso não transforma automaticamente uma UBS em serviço de diagnóstico por imagem. Sem treinamento, delimitação de escopo, supervisão, armazenamento adequado, critérios de encaminhamento e auditoria da qualidade, a tecnologia pode apenas deslocar incerteza de um ponto da rede para outro.

A medida será bem-sucedida se for acompanhada de **currículo de capacitação, número mínimo de exames supervisionados, protocolo por indicação, registro das imagens e avaliação periódica de concordância diagnóstica**.

Essa é uma inovação de baixo glamour e potencialmente alto impacto — justamente o tipo de tecnologia que merece ser avaliada pelo quanto resolve problemas concretos, não pela novidade do dispositivo.

Fonte: Ministério da Saúde — <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/setembro/500-ultrassons-portateis-fortalecem-atendimento-nas-unidades-basicas-de-saude>

05 · NESTA EDIÇÃO

Oncologia: o SUS está deixando de tratar medicamento oncológico como exceção administrativa permanente

O Ministério da Saúde destacou nesta semana a regulamentação do **Componente da Assistência Farmacêutica em Oncologia (AF-Onco)**. A formulação pode dar a impressão de que o componente nasceu agora; não nasceu. Ele foi instituído em outubro de 2025 e vem recebendo atos normativos sucessivos ao longo de 2026.

O que importa é o desenho que começa a se consolidar.

A arquitetura inclui:

- relação nacional de medicamentos;
- negociação nacional para aquisição;
- regras para medicamentos de altíssimo custo;
- autorização prévia em determinados cenários;
- registro por APAC oncológica específica;
- centrais de diluição para medicamentos de altíssimo custo;
- critérios de aquisição, distribuição, dispensação e acompanhamento.

Historicamente, a assistência oncológica brasileira combinou financiamento por procedimento, autonomia dos serviços habilitados e mecanismos heterogêneos de aquisição. O AF-Onco tenta criar uma camada mais explícita de **governança farmacêutica nacional**, especialmente à medida que terapias-alvo e imunoterapias elevam o custo e a complexidade logística.

O benefício potencial é reduzir heterogeneidade e aumentar poder de negociação. O risco é trocar fragmentação local por rigidez central caso incorporação, compra e distribuição não acompanhem rapidamente a evidência e a necessidade clínica.

O que deve ser observado nos próximos meses: tempo entre incorporação e disponibilidade real, desabastecimentos, diferença regional de acesso, custo efetivo por paciente e aderência aos PCDTs.

Fontes: Ministério da Saúde — Assistência Farmacêutica em Oncologia: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/daf/af-onco> Legislação AF-Onco: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/daf/af-onco/legislacao>

“Agora Tem Especialistas”: o dado importante é a distância entre contratar e entregar

O Ministério da Saúde informou que já formalizou **R\$ 1 bilhão** em créditos financeiros com **259 instituições de 21 estados**, prevendo mais de **600 mil procedimentos** para pacientes do SUS na rede privada e filantrópica.

Desse total anunciado, 458 mil procedimentos estão vinculados a Ofertas de Cuidados Integrados e 142 mil a cirurgias. Em Minas Gerais, a previsão divulgada é de **205 mil procedimentos**, com aproximadamente **R\$ 124,7 milhões** em créditos.

Mas o mesmo comunicado informa que apenas **23 estabelecimentos** haviam alcançado produção validada, somando **6,2 mil procedimentos**. Em Minas, quatro instituições citadas somavam pouco mais de **1,7 mil procedimentos** já realizados.

Esse contraste é precisamente o que uma revista de saúde deve preservar: **capacidade contratada não é cuidado entregue**.

Há ainda um ponto que merece esclarecimento oficial: o texto do Ministério menciona “6,2 mil procedimentos realizados para 7,2 mil pacientes”, uma relação numérica que não é intuitiva se “procedimento” e “paciente atendido” estiverem sendo usados em seu sentido usual. Pode haver diferença de unidade de contabilização ou erro de redação; até esclarecimento, o número deve ser reproduzido com cautela.

A política é interessante porque usa créditos tributários para mobilizar capacidade ociosa ou negociável da rede privada em favor do SUS. Seu valor real será demonstrado por redução de filas e tempos de espera, e não pelo volume nominal dos contratos.

Fonte: Ministério da Saúde — Minas Gerais: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/setembro/pacientes-do-sus-em-minas-gerais-serao-atendidos-por-hospitais-particulares-para-a-realizacao-de-205-mil-procedimentos>

Radar da semana

07 · NESTA EDIÇÃO

Pesquisa Nacional de Saúde Mental: ainda não há resultado — e isso é importante dizer

A primeira Pesquisa Nacional de Saúde Mental está em coleta de campo. Até 28 de agosto, havia **1.011 entrevistas completas**, em 197 municípios de 26 unidades federativas; a meta é chegar a aproximadamente **10 mil entrevistas válidas**.

Ainda não há prevalências nacionais novas para publicar. A notícia relevante é metodológica: o Brasil está construindo uma linha de base probabilística específica para saúde mental, incluindo transtornos, violência, vulnerabilidade socioeconômica e acesso à Rede de Atenção Psicossocial.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/setembro/pesquisa-nacional-de-saude-mental-realiza-coleta-de-dados-em-197-municipios>

08 · NESTA EDIÇÃO

Multivacinação terminou; vacinação não

A Campanha Nacional de Multivacinação terminou em 1º de setembro com **mais de 8 milhões de doses aplicadas**. O encerramento da campanha não retira as vacinas do SUS. Em um contexto de casos importados de sarampo e circulação intensa nas Américas, caderneta atualizada continua sendo a medida prática mais importante.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/setembro/campanha-nacional-de-multivacinacao-encerra-nesta-terca-feira-1o-com-mais-de-8-milhoes-de-doses-aplicadas>

09 · NESTA EDIÇÃO

Saúde e clima: preparação para El Niño entrou na agenda operacional

Gestores de 26 estados e do Distrito Federal avançaram na elaboração de planos estaduais de enfrentamento dos efeitos sanitários esperados do El Niño. O impacto relevante não é apenas “calor”: inclui alterações em arboviroses, qualidade da água, eventos extremos, doenças respiratórias, segurança alimentar e capacidade dos serviços de saúde.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/setembro/sus-reforca-preparacao-em-todo-o-pais-para-antecipar-riscos-e-proteger-populacao-dos-impactos-do-el-nino>

10 · NESTA EDIÇÃO

Anvisa: terminou a transição regulatória para parte dos suplementos alimentares

Em 1º de setembro terminou o prazo de notificação, na Anvisa, para suplementos e alimentos para controle de peso abrangidos pelas regras de transição da RDC 843/2024. A ausência imediata de número de notificação no rótulo não torna automaticamente um lote já produzido irregular; data de fabricação, comunicação anterior, validade e rastreabilidade precisam ser consideradas.

Fonte: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2026/anvisa-alerta-e-orienta-sobre-o-prazo-de-adequacao-as-regras-de-regularizacao-de-alimentos>

O que a VIA leva desta semana

Três padrões atravessam quase todas as notícias relevantes:

1. **Norma não é implementação.** A lei da trombóise cria uma obrigação de organização; ainda é preciso medicamento, equipe, protocolo e rede de referência.
2. **Tecnologia não é desfecho.** UTI “inteligente”, ultrassom portátil e plataforma de RNA só se justificam quando demonstram desempenho, segurança, acesso e capacidade de escala.
3. **Número contratado não é número entregue.** Em políticas públicas de grande visibilidade, convém acompanhar produção validada, tempo de espera e resultado clínico — não apenas anúncios e capacidade nominal.

Essa é a função desta revista: não competir com o fluxo de notícias, mas reduzir a distância entre **o que foi anunciado, o que realmente mudou e o que ainda precisa ser demonstrado.**

11 · NESTA EDIÇÃO

Método editorial

Edição baseada prioritariamente em fontes primárias publicadas entre 30 de agosto e 6 de setembro de 2026: Presidência da República, Ministério da Saúde e Anvisa. Notícias institucionais foram lidas como descrição de decisão ou implementação administrativa, não como evidência automática de efetividade clínica. Quando uma afirmação de benefício depende de avaliação futura, isso foi explicitado.

Saúde na Última Semana — Revista Eletrônica VIA Dr Lucas HR — Médico Generalista (FMRP-USP) Iniciativa VIA — Vida Integrada e Autônoma *Ciência e Tecnologia a serviço do Cuidado.*

[Substack ↗](#)[YouTube ↗](#)[Instagram ↗](#)[Medium ↗](#)[GitHub ↗](#)[Doctoralia ↗](#)[WhatsApp ↗](#)

Dr Lucas HR Almeida — Médico Generalista (FMRP-USP) · CRM-SP 226836 | CRM-MG 109752
Iniciativa VIA — Vida Integrada e Autônoma · Ciência e Tecnologia a serviço do Cuidado.

Iniciativa VIA · Sobre o fundador